UE B1.3 · SEMESTRE 1 · 27 OCTOBRE 2026

VIH — QCM de révision

Pour chaque question, cocher les bonnes propositions parmi A à E. Le nombre de réponses attendues est annoncé pour chaque question. Les explications sont regroupées après les 50 questions.

50 questions | 5 thèmes | Corrigés après les questions

VIH, CD4 et sida — 10 questions

Q01 **Au sujet du VIH, quelles affirmations sont exactes ?** — 2 réponses · Facile

- ☐ **A.** Le VIH est un rétrovirus.
- ☐ **B.** Le VIH reste toujours à l'extérieur du génome de la cellule infectée.
- ☐ **C.** Une charge virale indétectable prouve que tous les réservoirs ont disparu.
- ☐ **D.** Il peut se multiplier sans cellule hôte.
- ☐ **E.** Un traitement efficace rend généralement l'infection contrôlable, sans guérison habituelle.

Q02 **La charge virale plasmatique VIH permet principalement de…** — 1 réponse · Facile

- ☐ **A.** Quantifier l'ARN viral circulant.
- ☐ **B.** Mesurer directement le nombre de lymphocytes T CD4.
- ☐ **C.** Elle permet, isolément, de poser le diagnostic de stade sida.
- ☐ **D.** Certifier à elle seule l'absence de réservoir d'ADN viral.
- ☐ **E.** Elle mesure directement la quantité de plaquettes circulantes.

Q03 **Concernant les lymphocytes T CD4, lesquelles de ces propositions sont correctes ?** — 2 réponses · Facile

- ☐ **A.** Ce sont des cellules immunitaires et non des hormones.
- ☐ **B.** Ils sont produits exclusivement par le foie.
- ☐ **C.** Ils sécrètent directement tous les anticorps circulants.
- ☐ **D.** Le VIH les cible et peut faire diminuer leur nombre.
- ☐ **E.** Leur numération n'apporte aucune information au suivi.

Q04 **Comment différencier infection VIH et stade sida ?** 3 réponses · Facile

- [ ] **A.** Toute personne infectée par le VIH est immédiatement au stade sida.
- [ ] **B.** La majorité des personnes traitées peuvent vivre avec le VIH sans être au stade sida.
- [ ] **C.** Le sida est un stade avancé de l'infection à VIH défini par des critères spécifiques.
- [ ] **D.** Une infection opportuniste chez un transplanté signifie automatiquement « sida ».
- [ ] **E.** Le stade sida peut être révélé par certaines infections opportunistes.

Q05 **Quel sens donner au repère de 200 CD4/mm³ utilisé dans le cours ?** 3 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** En dessous, le risque d'infections opportunistes augmente.
- [ ] **B.** Il suffit, isolément et sans autre critère, pour diagnostiquer tout sida.
- [ ] **C.** Il aide à reconnaître une immunodépression importante.
- [ ] **D.** Au-dessus, toute infection, dont la tuberculose, devient impossible.
- [ ] **E.** Il est utile pour réfléchir à certaines prophylaxies.

Q06 **Que permet la distinction entre ARN viral circulant et ADN proviral ?** 1 réponse · Difficile

- [ ] **A.** Distinguer mesure de réplication et persistance du virus intégré.
- [ ] **B.** Conclure que l'ADN proviral correspond à un anticorps.
- [ ] **C.** Une charge virale supprimée exclut tout rebond après arrêt des ARV.
- [ ] **D.** Considérer que les deux mesures ont exactement le même objectif.
- [ ] **E.** L'ADN proviral mesure uniquement les plaquettes.

Q07 **Une personne sous traitement a une charge virale durablement supprimée. Quels messages sont adaptés ?** 3 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Son VIH a nécessairement été éliminé de toutes ses cellules.
- [ ] **B.** Le traitement doit être poursuivi selon la prescription.
- [ ] **C.** La suppression virale favorise la restauration des CD4.
- [ ] **D.** On peut supprimer tout suivi médical.
- [ ] **E.** Le contrôle durable du VIH améliore fortement les perspectives de vie.

Q08 **Quel lien entre VIH, immunité et tumeurs est évoqué dans la séance ?** 2 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Les CD4 participent aussi à des défenses immunitaires contre des tumeurs.
- [ ] **B.** Le risque tumoral dépend uniquement du nombre de partenaires sexuels.
- [ ] **C.** L'immunodépression peut contribuer à un sur-risque de certaines tumeurs.
- [ ] **D.** Un traitement antirétroviral efficace transforme toute tumeur en infection.
- [ ] **E.** Tous les cancers observés chez les PVVIH proviennent d'une transformation tumorale des CD4.

Q09 **À propos du vocabulaire employé avec les patients, que retenir ?** 2 réponses · Facile

- [ ] **A.** « PVVIH » signifie « personne vivant avec le VIH ».
- [ ] **B.** L'expression « patient VIH » est toujours la formulation recommandée.
- [ ] **C.** Une terminologie non stigmatisante est importante pour la relation de soins.
- [ ] **D.** La confidentialité n'a pas d'importance quand le patient est traité.
- [ ] **E.** Le statut VIH doit être affiché publiquement pour faciliter les soins.

Q10 **Une personne immunodéprimée sans infection VIH présente une pneumocystose. Quels raisonnements sont justes ?** 3 réponses · Difficile

- [ ] **A.** L'infection opportuniste peut aussi exister hors du VIH.
- [ ] **B.** Il faut automatiquement la déclarer au stade sida.
- [ ] **C.** L'histoire clinique et la cause de l'immunodépression comptent.
- [ ] **D.** Toute pneumocystose est une infection virale.
- [ ] **E.** La présence d'une infection opportuniste ne permet pas à elle seule de conclure à un VIH.

Transmission et évolution clinique

10 questions

Q11 **Quelles voies de transmission du VIH ont été décrites ?** 1 réponse · Facile

- [ ] **A.** La transmission sexuelle.
- [ ] **B.** Le simple fait de parler avec une PVVIH.
- [ ] **C.** Un contact de sang avec la peau intacte entraîne toujours une infection VIH.
- [ ] **D.** La transmission parent-enfant ne nécessite jamais aucune prévention.
- [ ] **E.** Le contact de la main sur une peau saine.

Q12 **Concernant « indétectable = intransmissible » (I = I), que faut-il retenir ?** 2 réponses · Facile

- [ ] **A.** Le principe concerne la transmission sexuelle sous suppression virale durable.
- [ ] **B.** Il dispense de toutes les précautions standard lors d'un prélèvement sanguin.
- [ ] **C.** C'est un message central pour réduire la stigmatisation.
- [ ] **D.** Il signifie que la personne ne possède plus d'ADN viral intégré.
- [ ] **E.** Une fois indétectable, le suivi médical peut être définitivement arrêté.

Q13 **En l'absence de traitement, comment peut évoluer l'infection VIH ?** 2 réponses · Facile

- [ ] **A.** Primo-infection avec réplication virale initiale importante.
- [ ] **B.** Disparition certaine du virus après quelques jours.
- [ ] **C.** Phase de latence clinique pouvant être peu symptomatique.
- [ ] **D.** La diminution des CD4 s'accompagne toujours de la disparition du VIH.
- [ ] **E.** Absence de réplication virale pendant toute la latence.

Q14 **Quels symptômes peuvent évoquer une primo-infection VIH ?** 3 réponses · Facile

- [ ] **A.** Fièvre et syndrome pseudo-grippal.
- [ ] **B.** Éruption cutanée et adénopathies.
- [ ] **C.** Dyspnée exclusivement, sans autre signe possible.
- [ ] **D.** Pharyngite ou céphalées.
- [ ] **E.** Un tableau clinique toujours pathognomonique.

Q15 **À propos du caractère asymptomatique de l'infection VIH, quelles propositions sont justes ?** 3 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** La primo-infection peut ne provoquer aucun signe ressenti.
- [ ] **B.** Une latence clinique peut durer sans symptôme évident.
- [ ] **C.** L'absence de symptôme suffit à écarter toute contamination récente.
- [ ] **D.** Le virus peut rester détectable malgré une latence clinique.
- [ ] **E.** La latence est synonyme de guérison définitive.

Q16 **Quels éléments biologiques sont évoqués pendant la primo-infection ?** 1 réponse · Difficile

- [ ] **A.** Une possible cytolyse hépatique.
- [ ] **B.** Une thrombopénie est systématiquement présente chez tous les patients.
- [ ] **C.** Une absence obligatoire de toute anomalie sanguine.
- [ ] **D.** L'hémogramme est toujours parfaitement normal pendant la primo-infection.
- [ ] **E.** Une numération CD4 à elle seule toujours suffisante pour diagnostiquer le VIH.

Q17 **Quelle conduite face à un zona est cohérente avec le cours ?** 2 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Il faut conclure que tout zona signifie VIH.
- [ ] **B.** Le zona peut faire envisager une immunodépression.
- [ ] **C.** Il peut conduire à proposer une évaluation et un dépistage VIH adaptés.
- [ ] **D.** Il ne survient jamais chez une personne immunocompétente.
- [ ] **E.** Un zona ne peut jamais conduire à envisager un dépistage VIH.

Q18 **À propos des données épidémiologiques évoquées pendant le cours, quelle lecture est prudente ?** 2 réponses · Difficile

- [ ] **A.** Les chiffres doivent être rattachés à leur année de référence.
- [ ] **B.** Les chiffres d'une diapositive de 2022 décrivent nécessairement la situation en 2026.
- [ ] **C.** Le cours signale une épidémie mondiale persistante malgré les traitements.
- [ ] **D.** En cas de contradiction, on adopte sans contrôle le chiffre le plus élevé.
- [ ] **E.** Une catégorie de population suffit à présumer de la sérologie d'une personne.

Q19 **Quelle différence entre contact quotidien et soin invasif avec une PVVIH ?** 3 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Le contact social ordinaire n'exige pas de protection exceptionnelle liée au VIH.
- [ ] **B.** Les précautions standard dépendent aussi du geste et du risque de sang.
- [ ] **C.** Une conversation avec une PVVIH impose systématiquement un masque FFP2.
- [ ] **D.** Un prélèvement sanguin justifie la prévention habituelle des expositions au sang.
- [ ] **E.** Les gants sont obligatoires lors de tout contact visuel avec une PVVIH.

Q20 **Pourquoi la prévention du VIH ne doit-elle pas reposer sur une logique de culpabilisation ?** 3 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Elle peut empêcher le dialogue et l'accès au dépistage.
- [ ] **B.** L'enseignante encourage une information sans jugement.
- [ ] **C.** Le nombre de partenaires suffit à poser le diagnostic.
- [ ] **D.** PrEP, préservatif et dépistage doivent être discutés avec la personne.
- [ ] **E.** La prévention est inutile si la personne est anxieuse.

Infections opportunistes et complications

10 questions

Q21 **Devant une infection opportuniste chez une PVVIH, quels axes de prise en charge sont évoqués ?** 2 réponses · Facile

- [ ] **A.** Traiter l'infection opportuniste identifiée.
- [ ] **B.** Contrôler l'infection VIH par un traitement adapté.
- [ ] **C.** Arrêter nécessairement les antirétroviraux de façon définitive.
- [ ] **D.** Il faut renoncer à tout suivi de la récupération immunitaire.
- [ ] **E.** Ignorer les autres infections opportunistes possibles.

Q22 — **Concernant la tuberculose au cours d'une infection VIH, quelles propositions sont justes ?** — 2 réponses · Facile

- [ ] **A.** Elle peut apparaître même avec des CD4 relativement conservés.
- [ ] **B.** Elle est exclusivement extrapulmonaire chez les PVVIH.
- [ ] **C.** Une tuberculose doit faire envisager un dépistage VIH.
- [ ] **D.** Une tuberculose pulmonaire contagieuse impose uniquement des précautions gouttelettes.
- [ ] **E.** Les précautions gouttelettes suffisent nécessairement dans toute tuberculose pulmonaire.

Q23 — **Quels signes évoquent une pneumocystose dans la séance ?** — 2 réponses · Facile

- [ ] **A.** Toux.
- [ ] **B.** Dyspnée.
- [ ] **C.** La pneumocystose est causée par un virus herpétique.
- [ ] **D.** Hémiplégie isolée comme manifestation pulmonaire typique.
- [ ] **E.** Nodules violacés cutanés comme signe cardinal.

Q24 — **À propos du cotrimoxazole et de la pneumocystose, que retient-on ?** — 3 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Il est cité comme traitement de la pneumocystose.
- [ ] **B.** Il est évoqué à visée prophylactique lors d'une forte immunodépression.
- [ ] **C.** Il remplace tous les antirétroviraux du VIH.
- [ ] **D.** Le seuil de 200 CD4/mm³ est un repère de cours pour discuter une prévention.
- [ ] **E.** Il est un vaccin contre le VIH.

Q25 — **Quels signes ou situations orientent vers une toxoplasmose cérébrale ?** — 3 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Déficit neurologique focal de type hémiplégie.
- [ ] **B.** Crise d'épilepsie.
- [ ] **C.** Abcès ou lésions cérébrales à l'imagerie.
- [ ] **D.** Rétinite comme unique signe obligatoire.
- [ ] **E.** Présence obligatoire d'une tuberculose pulmonaire associée.

Q26 — **La cryptococcose opportuniste est évoquée avec quelles caractéristiques ?** — 1 réponse · Intermédiaire

- [ ] **A.** Une méningite ou des céphalées fébriles.
- [ ] **B.** Le CMV n'atteint jamais le tube digestif.
- [ ] **C.** Le CMV ne peut avoir aucune atteinte neurologique.
- [ ] **D.** Une gastro-entérite sans atteinte neurologique possible.
- [ ] **E.** Un traitement reposant uniquement sur le préservatif.

Q27 **Quelles atteintes emblématiques du CMV sont décrites ?** 2 réponses · Intermédiaire

- ☐ **A.** Rétinite pouvant menacer la vision.
- ☐ **B.** Colite avec diarrhées.
- ☐ **C.** Un traitement efficace exclut toute inflammation cardiovasculaire.
- ☐ **D.** Une pneumocystose due au même agent CMV.
- ☐ **E.** Une maladie exclusivement cutanée.

Q28 **Quels liens entre VIH et cancers sont présentés ?** 2 réponses · Intermédiaire

- ☐ **A.** Kaposi est associé au HHV-8.
- ☐ **B.** Certains cancers liés au papillomavirus peuvent être plus fréquents.
- ☐ **C.** Une infection VIH rend tous les lymphomes impossibles.
- ☐ **D.** Tous les cancers des PVVIH sont causés directement par le VIH lui-même.
- ☐ **E.** Un traitement antirétroviral rend tous les dépistages inutiles.

Q29 **Pourquoi le risque cardiovasculaire apparaît-il dans le cours ?** 3 réponses · Difficile

- ☐ **A.** Une réplication persistante peut entretenir une inflammation.
- ☐ **B.** Cette inflammation est présentée comme l'un des facteurs de complications.
- ☐ **C.** Une atteinte cardiovasculaire est impossible en dehors du stade sida.
- ☐ **D.** L'évaluation globale des comorbidités reste pertinente.
- ☐ **E.** Il suffit de compter les CD4 pour exclure tout facteur cardiovasculaire.

Q30 **Quelles associations agent–manifestation sont correctes ?** 3 réponses · Facile

- ☐ **A.** Pneumocystose — infection fongique pulmonaire.
- ☐ **B.** Toxoplasmose — abcès cérébraux possibles.
- ☐ **C.** Cryptococcose — méningite possible.
- ☐ **D.** CMV — maladie de Kaposi.
- ☐ **E.** Tuberculose — infection exclusivement virale.

Dépistage, traitement et maternité

10 questions

Q31 **Quels moyens de dépistage du VIH sont cités ?** 1 réponse · Facile

- ☐ **A.** Sérologie VIH.
- ☐ **B.** Le TROD ne mesure que le nombre de CD4.
- ☐ **C.** Une photographie des lésions cutanées est un autotest VIH.
- ☐ **D.** Simple numération des lymphocytes CD4 comme diagnostic suffisant.
- ☐ **E.** Photographie des lésions cutanées comme preuve de VIH.

Q32 **Un autotest VIH revient positif. Quel message est adapté ?** 2 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Un examen de confirmation doit être organisé.
- [ ] **B.** Le diagnostic définitif et le stade sida sont établis immédiatement par cet autotest.
- [ ] **C.** La personne doit être orientée vers un parcours de soins adapté.
- [ ] **D.** La confidentialité est inutile dès qu'un autotest est réactif.
- [ ] **E.** Un autotest positif permet de prescrire soi-même des antirétroviraux.

Q33 **Lors du suivi d'une PVVIH, quels éléments sont centraux ?** 2 réponses · Facile

- [ ] **A.** Charge virale VIH.
- [ ] **B.** Numération T CD4.
- [ ] **C.** La charge virale indétectable élimine toute question d'observance.
- [ ] **D.** Mesure isolée de la glycémie comme seul examen du VIH.
- [ ] **E.** Arrêt systématique du suivi dès la suppression virale.

Q34 **Pourquoi rechercher d'autres IST chez une personne ayant un VIH ?** 3 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Il peut y avoir des co-infections.
- [ ] **B.** Le cours cite notamment syphilis, hépatites et infections à Chlamydia/gonocoque.
- [ ] **C.** Une infection VIH protège des autres IST.
- [ ] **D.** La prévention et le dépistage restent nécessaires.
- [ ] **E.** Le test VIH détecte automatiquement toutes les IST.

Q35 **Que retenir du traitement antirétroviral (ARV) dans ce cours ?** 3 réponses · Facile

- [ ] **A.** Il est proposé dès que possible après le diagnostic.
- [ ] **B.** Il doit généralement être poursuivi au long cours, sans arrêt autonome.
- [ ] **C.** Il a pour objectif une suppression durable de la charge virale.
- [ ] **D.** Il est arrêté dès la première mesure indétectable.
- [ ] **E.** Il consiste toujours exclusivement en trois comprimés distincts par jour.

Q36 **À propos des schémas ARV évoqués, lesquelles des propositions sont justes ?** 1 réponse · Intermédiaire

- [ ] **A.** Le cours mentionne des bithérapies possibles dans certaines situations.
- [ ] **B.** Il n'existe jamais de comprimé associant plusieurs antirétroviraux.
- [ ] **C.** Le choix des ARV ne dépend jamais des comorbidités.
- [ ] **D.** Tout patient reçoit obligatoirement la même association de médicaments.
- [ ] **E.** Le nombre de comprimés permet à lui seul d'évaluer l'efficacité.

Q37 — **Quels noms de traitements combinés sont cités à titre d'exemples pendant la séance ?** — 2 réponses · Difficile

- [ ] **A.** Biktarvy.
- [ ] **B.** Dovato.
- [ ] **C.** Chaque PVVIH doit recevoir la même molécule, indépendamment des co-infections.
- [ ] **D.** Cotrimoxazole comme combinaison curative du VIH.
- [ ] **E.** Ganciclovir comme trithérapie antirétrovirale standard.

Q38 — **Une PVVIH bien contrôlée souhaite une grossesse. Quels messages sont conformes à la séance ?** — 2 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Un projet parental peut être envisagé avec un suivi spécialisé.
- [ ] **B.** Une PMA est toujours obligatoire.
- [ ] **C.** La charge virale n'a aucune importance pendant la grossesse.
- [ ] **D.** L'observance et le suivi de la charge virale pendant la grossesse sont importants.
- [ ] **E.** Une grossesse doit être systématiquement interdite aux PVVIH.

Q39 — **Concernant l'allaitement chez une PVVIH contrôlée, quel raisonnement est approprié ?** — 3 réponses · Difficile

- [ ] **A.** L'allaitement est toujours interdit, sans exception.
- [ ] **B.** La séance évoque une décision possible dans certaines situations sélectionnées.
- [ ] **C.** Le suivi de la mère et du nourrisson reste essentiel.
- [ ] **D.** L'absence de risque doit être garantie sans aucune condition.
- [ ] **E.** L'équipe spécialisée doit discuter bénéfices, conditions et prévention avec la patiente.

Q40 — **Quel rôle attribuer à la prophylaxie néonatale lors d'une grossesse chez une PVVIH ?** — 3 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Elle peut faire partie de la stratégie de prévention pour le nouveau-né.
- [ ] **B.** Elle remplace l'ensemble du suivi virologique maternel.
- [ ] **C.** Sa durée et ses modalités sont décidées selon la situation clinique.
- [ ] **D.** Le cours mentionne une prophylaxie du nourrisson dans le parcours spécialisé.
- [ ] **E.** Elle signifie que tous les bébés sont déjà infectés.

PrEP, TPE et rôle infirmier — 10 questions

Q41 **À propos de la prophylaxie pré-exposition (PrEP), que faut-il retenir ?** 1 réponse · Facile

- [ ] **A.** Elle s'adresse à des personnes VIH négatives exposées à un risque.
- [ ] **B.** Elle n'est proposée qu'après une exposition avérée.
- [ ] **C.** Elle utilise exclusivement un vaccin vivant.
- [ ] **D.** Elle est identique à un vaccin.
- [ ] **E.** Elle permet d'abandonner automatiquement le dépistage des autres IST.

Q42 **Quels messages sur la PrEP sont cohérents avec le cours ?** 2 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Elle peut être discutée après une IST, selon l'exposition et les besoins.
- [ ] **B.** Elle remplace toutes les mesures de prévention des autres IST.
- [ ] **C.** Des modalités orales sont évoquées pendant la séance.
- [ ] **D.** Toutes les modalités injectables sont disponibles partout et sans condition.
- [ ] **E.** Elle traite à elle seule une infection VIH diagnostiquée.

Q43 **Qu'est-ce qui différencie PrEP et traitement post-exposition (TPE/PEP) ?** 2 réponses · Facile

- [ ] **A.** La PrEP intervient avant une exposition potentielle.
- [ ] **B.** Le TPE est discuté après une exposition à risque.
- [ ] **C.** Une consultation après plusieurs mois présente la même urgence pour le TPE.
- [ ] **D.** La PrEP et le TPE correspondent à une vaccination identique.
- [ ] **E.** Le TPE est indiqué automatiquement après n'importe quel contact social.

Q44 **Quelles données d'une exposition récente doivent être recueillies en priorité ?** 3 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Le délai depuis le contact.
- [ ] **B.** La nature de l'exposition et du liquide concerné.
- [ ] **C.** Des éléments utiles sur le contexte et la personne source, si disponibles.
- [ ] **D.** Le jugement moral porté sur la vie sexuelle.
- [ ] **E.** La supposition qu'un contact courant est toujours dangereux.

Q45 **Quels repères de TPE sont explicitement donnés pendant le cours ?** 3 réponses · Intermédiaire

- [ ] **A.** Une prise en charge dans les 72 h suivant l'exposition, idéalement très précoce.
- [ ] **B.** Un traitement antirétroviral de 28 jours est évoqué.
- [ ] **C.** Un avis médical urgent est nécessaire.
- [ ] **D.** Il faut toujours attendre la survenue d'une fièvre avant d'agir.
- [ ] **E.** Le TPE est une immunisation vaccinale à dose unique.

Q46 **Après un accident d'exposition au sang (AES), quelles étapes sont citées ?** 1 réponse · Intermédiaire

- [ ] **A.** Une évaluation rapide du risque et une orientation médicale.
- [ ] **B.** Aucun examen de suivi n'est utile après un AES.
- [ ] **C.** Un AES chez un IDE ne nécessite jamais une déclaration d'accident du travail.
- [ ] **D.** Une décision thérapeutique autonome de l'IDE sans consultation.
- [ ] **E.** L'absence de toute traçabilité si le patient source est inconnu.

Q47 **Dans le cas de M. M., anxieux après un rapport non protégé, quelle posture infirmière est adaptée ?** 2 réponses · Facile

- [ ] **A.** Accueillir l'anxiété sans culpabiliser.
- [ ] **B.** Informer que des traitements efficaces existent et organiser le dépistage.
- [ ] **C.** La date du contact ne sert jamais à déterminer l'urgence.
- [ ] **D.** Annoncer immédiatement qu'il va mourir du sida.
- [ ] **E.** Affirmer sans test qu'il a forcément contracté le VIH.

Q48 **Un étudiant propose de résoudre les huit situations du cas final en cochant « TPE oui/non ». Que répondre à partir des sources fournies ?** 2 réponses · Difficile

- [ ] **A.** La correction de ce dernier exercice n'a pas été donnée oralement.
- [ ] **B.** Il faut fabriquer des réponses pour compléter la banque.
- [ ] **C.** L'analyse doit distinguer type d'exposition, délai et contexte.
- [ ] **D.** Les huit situations ont toutes reçu une correction orale officielle.
- [ ] **E.** Tout cas cité dans une diapositive justifie automatiquement un TPE.

Q49 **Que comprennent les précautions et le rôle IDE auprès d'une PVVIH ?** 3 réponses · Facile

- [ ] **A.** Appliquer les précautions standard en fonction du soin.
- [ ] **B.** Utiliser les gants lors de gestes exposant au sang selon les bonnes pratiques.
- [ ] **C.** Préserver la confidentialité et éviter la stigmatisation.
- [ ] **D.** Imposer un isolement Air à toute PVVIH sans tuberculose.
- [ ] **E.** Renoncer à tout examen clinique de peur d'une contagion par simple contact.

Q50 **Quelles composantes de la prise en charge globale sont soulignées par l'enseignante ?** 3 réponses · Facile

- [ ] **A.** Éducation thérapeutique et compréhension du traitement.
- [ ] **B.** Soutien psychosocial et accès aux ressources si précarité.
- [ ] **C.** Coordination des professionnels et accompagnement sans jugement.
- [ ] **D.** Suivi limité à une ordonnance sans dialogue.
- [ ] **E.** Abandon de l'information sur les vaccinations et autres IST.

Corrigés argumentés

Les clés sont indiquées uniquement dans cette partie. Les justifications expliquent la réponse et signalent les confusions fréquentes ; elles reprennent les limites des sources du cours.

VIH, CD4 et sida

10 questions

Q01 Au sujet du VIH, quelles affirmations sont exactes ?

Bonnes réponses : A, E

Le VIH est un rétrovirus dont l'ARN est rétrotranscrit en ADN, puis intégré ; les antirétroviraux contrôlent la réplication sans éliminer les réservoirs.

Propositions à écarter : C est faux : indétectable ne signifie pas éradiqué. D est faux : la multiplication du virus requiert une cellule. B : Le VIH peut intégrer son ADN dans le génome cellulaire.

Q02 La charge virale plasmatique VIH permet principalement de...

Bonne réponse : A

La charge virale est une mesure d'ARN viral, utilisée pour suivre la réplication et la réponse thérapeutique.

Propositions à écarter : B : le nombre de CD4 est un autre examen. D : un réservoir proviral peut persister malgré une charge virale basse. C : La charge virale seule ne définit pas le stade sida. E : La numération plaquettaire est un autre examen.

Q03 Concernant les lymphocytes T CD4, lesquelles de ces propositions sont correctes ?

Bonnes réponses : A, D

Les T CD4 jouent un rôle majeur dans la coordination de l'immunité et sont des cibles du VIH.

Propositions à écarter : C : la production d'anticorps relève des lymphocytes B/plasmocytes. E : la numération CD4 renseigne sur l'immunodépression. B : Les lymphocytes T CD4 sont des cellules immunitaires, non des protéines hépatiques.

Q04 Comment différencier infection VIH et stade sida ?

Bonnes réponses : B, C, E

VIH désigne l'infection ; sida désigne un stade avancé, notamment lié à des affections définissant ce stade.

Propositions à écarter : A confond infection et stade. D confond sida avec d'autres causes d'immunodépression.

Q05 Quel sens donner au repère de 200 CD4/mm³ utilisé dans le cours ?

Bonnes réponses : A, C, E

Le cours utilise le seuil de 200 CD4/mm³ comme repère de vulnérabilité et de prévention de certaines infections.

Propositions à écarter : B : le sida ne se résume pas au seul seuil. D : la tuberculose peut survenir malgré des CD4 conservés.

Q06 **Que permet la distinction entre ARN viral circulant et ADN proviral ?**

Bonne réponse : A

L'ARN plasmatique reflète la réplication mesurée ; l'ADN proviral correspond à l'intégration du virus dans des cellules, participant à la persistance.

Propositions à écarter : B : ADN viral ≠ anticorps. D : examens et significations distincts. C : Le VIH peut recommencer à se répliquer après l'arrêt du traitement. E : L'ADN proviral est un marqueur viral, non une mesure de l'hémogramme.

Q07 **Une personne sous traitement a une charge virale durablement supprimée. Quels messages sont adaptés ?**

Bonnes réponses : B, C, E

Le maintien du traitement et du suivi permet de contrôler le virus et de restaurer l'immunité ; vivre avec le VIH traité peut être proche de la normale.

Propositions à écarter : A : réservoirs persistants. D : suivi et observance restent nécessaires.

Q08 **Quel lien entre VIH, immunité et tumeurs est évoqué dans la séance ?**

Bonnes réponses : A, C

L'enseignante relie l'affaiblissement de l'immunité et certains cancers associés notamment à des virus oncogènes.

Propositions à écarter : B : ce n'est pas le mécanisme exposé. D : cancer et infection ne sont pas interchangeables. E : Les associations tumorales sont diverses, notamment avec HPV et HHV-8.

Q09 **À propos du vocabulaire employé avec les patients, que retenir ?**

Bonnes réponses : A, C

Le cours insiste sur l'expression PVVIH et la lutte contre les stéréotypes et la stigmatisation.

Propositions à écarter : B : étiquetage réducteur déconseillé dans la séance. D : confidentialité indispensable. E : Le secret et la confidentialité demeurent indispensables.

Q10 **Une personne immunodéprimée sans infection VIH présente une pneumocystose. Quels raisonnements sont justes ?**

Bonnes réponses : A, C, E

Le cours compare le VIH à d'autres immunodépressions (dont la transplantation) : une infection opportuniste n'établit pas à elle seule le sida.

Propositions à écarter : B : sida suppose l'infection VIH et des critères spécifiques. D : la pneumocystose est due à un champignon.

Transmission et évolution clinique

10 questions

Q11 **Quelles voies de transmission du VIH ont été décrites ?**

Bonne réponse : A

Le cours décrit les voies sexuelle, sanguine et parent-enfant ; les contacts sociaux ordinaires ne transmettent pas le VIH.

Propositions à écarter : B et E relèvent de contacts courants ne constituant pas une voie d'infection VIH. C : Le risque dépend du type d'exposition et d'une porte d'entrée. D : Un suivi spécialisé et des mesures préventives peuvent être nécessaires.

Q12 **Concernant « indétectable = intransmissible » (I = I), que faut-il retenir ?**

Bonnes réponses : A, C

I = I signifie qu'une personne durablement indétectable sous traitement ne transmet pas sexuellement le VIH ; le cours insiste sur le bénéfice clinique et social de ce message.

Propositions à écarter : B : précautions standard maintenues. D : réservoir viral non éliminé. E : Le suivi reste important malgré la suppression virale.

Q13 **En l'absence de traitement, comment peut évoluer l'infection VIH ?**

Bonnes réponses : A, C

Sans traitement, le cours décrit une primo-infection, une latence clinique puis une immunodépression progressive.

Propositions à écarter : B : persistance virale. E : latence clinique ≠ virus biologiquement indétectable. D : La diminution des CD4 résulte de l'activité de l'infection, pas de sa guérison.

Q14 **Quels symptômes peuvent évoquer une primo-infection VIH ?**

Bonnes réponses : A, B, D

La séance mentionne fièvre, myalgies, pharyngite, céphalées, éruption et adénopathies, avec possibilité d'absence de symptômes.

Propositions à écarter : C : la clinique est variable. E : ces signes ne permettent pas, seuls, le diagnostic.

Q15 **À propos du caractère asymptomatique de l'infection VIH, quelles propositions sont justes ?**

Bonnes réponses : A, B, D

L'absence de symptôme ne garantit pas l'absence de VIH ; pendant la latence, le virus n'a pas disparu.

Propositions à écarter : C : une exposition peut nécessiter des examens. E : la persistance virale continue.

Q16 **Quels éléments biologiques sont évoqués pendant la primo-infection ?**

Bonne réponse : A

Le cours évoque notamment cytolyse, syndrome mononucléosique, lymphopénie/neutropénie et thrombopénie.

Propositions à écarter : C : anomalies possibles. E : diagnostic VIH par examens adaptés, non par CD4 isolés. B : Une thrombopénie peut exister mais n'est pas obligatoire. D : La séance décrit des anomalies possibles des cellules sanguines.

Q17 **Quelle conduite face à un zona est cohérente avec le cours ?**

Bonnes réponses : B, C

L'enseignante mentionne le zona comme signe pouvant inciter à rechercher une cause d'immunodépression, sans en faire une preuve de VIH.

Propositions à écarter : A et D : un zona a d'autres causes et survient aussi sans VIH. E : L'enseignante cite le zona comme une situation pouvant mener au dépistage.

Q18 **À propos des données épidémiologiques évoquées pendant le cours, quelle lecture est prudente ?**

Bonnes réponses : A, C

La présentation cite des repères datés et comporte une divergence pour un chiffre français : le raisonnement attendu porte sur dates, dépistage et prudence.

Propositions à écarter : B : ne pas actualiser sans données. E : aucune identité/pratique ne permet de conclure individuellement. D : Une contradiction source doit être explicitement réservée.

Q19 **Quelle différence entre contact quotidien et soin invasif avec une PVVIH ?**

Bonnes réponses : A, B, D

Le cours insiste sur l'absence de risque social ordinaire et l'application de précautions standard lors des gestes exposant au sang.

Propositions à écarter : C et E : protections exceptionnelles liées au seul statut non justifiées.

Q20 **Pourquoi la prévention du VIH ne doit-elle pas reposer sur une logique de culpabilisation ?**

Bonnes réponses : A, B, D

La séance demande une communication non moralisatrice et personnalisée, notamment pour les personnes vulnérables ou anxieuses.

Propositions à écarter : C : pas de diagnostic par comportement. E : information adaptée reste utile.

Infections opportunistes et complications

10 questions

Q21 **Devant une infection opportuniste chez une PVVIH, quels axes de prise en charge sont évoqués ?**

Bonnes réponses : A, B

La double approche soulignée à l'oral vise le traitement de l'infection en cours et le contrôle du VIH pour restaurer les défenses.

Propositions à écarter : C et E sont contraires aux objectifs ; le calendrier thérapeutique reste médical et individualisé. D : La récupération immunitaire fait partie de l'objectif du traitement.

Q22 **Concernant la tuberculose au cours d'une infection VIH, quelles propositions sont justes ?**

Bonnes réponses : A, C

L'enseignante insiste sur dépistage VIH devant une tuberculose et précautions Air en cas de tuberculose pulmonaire contagieuse.

Propositions à écarter : B : atteintes pulmonaires fréquentes, mais aussi extrapulmonaires. E : le cours distingue Air de gouttelettes. D : Le cours insiste sur les précautions Air.

Q23 **Quels signes évoquent une pneumocystose dans la séance ?**

Bonnes réponses : A, B

La pneumocystose est décrite comme une infection fongique pulmonaire pouvant entraîner toux, dyspnée et fièvre, parfois gravité respiratoire.

Propositions à écarter : D : évoque plutôt un problème neurologique. E : fait penser à Kaposi, non à une pneumocystose. C : La pneumocystose est une infection fongique.

Q24 **À propos du cotrimoxazole et de la pneumocystose, que retient-on ?**

Bonnes réponses : A, B, D

Le cours mentionne cotrimoxazole pour traiter et prévenir la pneumocystose chez certaines PVVIH avec CD4 bas.

Propositions à écarter : C et E : antibactérien/antipneumocystose ≠ traitement complet du VIH ni vaccin.

Q25 **Quels signes ou situations orientent vers une toxoplasmose cérébrale ?**

Bonnes réponses : A, B, C

L'atteinte cérébrale toxoplasmique peut donner déficit focal, crises et lésions à l'imagerie ; l'enseignante évoque un tableau initialement confondu avec un AVC.

Propositions à écarter : D : atteinte oculaire non présentée comme signe cardinal ici. E : aucune tuberculose obligatoire.

Q26 **La cryptococcose opportuniste est évoquée avec quelles caractéristiques ?**

Bonne réponse : A

Cryptococcose : infection fongique souvent neurologique, parfois avec hypertension intracrânienne et ponctions lombaires répétées ; repère oral CD4 souvent très bas.

Propositions à écarter : D : l'atteinte neurologique est centrale dans la présentation. E : la prise en charge est antifongique spécialisée. B : La colite à CMV est évoquée. C : Une atteinte neurologique est possible dans certaines situations.

Q27 **Quelles atteintes emblématiques du CMV sont décrites ?**

Bonnes réponses : A, B

Le CMV peut provoquer rétinite, colite, et certaines atteintes neurologiques ou pulmonaires ; des antiviraux spécifiques sont cités.

Propositions à écarter : D : pneumocystose = autre agent fongique. E : le CMV n'est pas limité à la peau. C : Le suivi cardiovasculaire reste pertinent.

Q28 **Quels liens entre VIH et cancers sont présentés ?**

Bonnes réponses : A, B

Le cours cite sarcome de Kaposi/HHV-8, lymphomes et certaines tumeurs associées aux HPV.

Propositions à écarter : D : plusieurs agents et mécanismes entrent en jeu. E : prévention et suivi restent nécessaires. C : Le cours évoque un sur-risque de certains lymphomes.

Q29 **Pourquoi le risque cardiovasculaire apparaît-il dans le cours ?**

Bonnes réponses : A, B, D

La séance relie réplication/inflammation et complications cardiovasculaires, d'où une approche globale.

Propositions à écarter : C : les comorbidités ne sont pas limitées au sida. E : les CD4 ne remplacent pas l'évaluation clinique.

Q30 **Quelles associations agent–manifestation sont correctes ?**

Bonnes réponses : A, B, C

Les trois premières associations correspondent aux tableaux typiques explicités par l'enseignante.

Propositions à écarter : D : Kaposi est associé au HHV-8. E : tuberculose due à une mycobactérie, non à un virus.

Dépistage, traitement et maternité

10 questions

Q31 **Quels moyens de dépistage du VIH sont cités ?**

Bonne réponse : A

La séance cite sérologie, TROD et autotest ; les résultats réactifs rapides nécessitent une confirmation selon le parcours diagnostique.

Propositions à écarter : D et E : ne remplacent pas le diagnostic biologique VIH. B : Le TROD est utilisé pour le dépistage du VIH et non la numération CD4. C : Le diagnostic passe par des tests biologiques adaptés.

Q32 **Un autotest VIH revient positif. Quel message est adapté ?**

Bonnes réponses : A, C

L'enseignante rappelle de confirmer un test rapide réactif par la démarche biologique adaptée et d'accompagner la personne.

Propositions à écarter : B : résultat rapide non suffisant pour conclure au stade. E : traitement et prescription exigent une prise en charge médicale. D : Le secret et le respect de la personne demeurent essentiels.

Q33 **Lors du suivi d'une PVVIH, quels éléments sont centraux ?**

Bonnes réponses : A, B

La charge virale, les CD4 et l'observance permettent de suivre contrôle de réplication, récupération immunitaire et continuité des soins.

Propositions à écarter : D : glycémie non spécifique. E : suivi maintenu même sous contrôle virologique. C : L'observance doit rester accompagnée sur le long terme.

Q34 **Pourquoi rechercher d'autres IST chez une personne ayant un VIH ?**

Bonnes réponses : A, B, D

L'enseignante insiste sur la recherche d'autres IST, car des expositions communes peuvent conduire à plusieurs infections.

Propositions à écarter : C : VIH n'immunise pas contre les IST. E : dépistages spécifiques nécessaires.

Q35 **Que retenir du traitement antirétroviral (ARV) dans ce cours ?**

Bonnes réponses : A, B, C

Le traitement précoce et durable est fortement souligné ; il contrôle la réplication et vise une charge virale indétectable.

Propositions à écarter : D : arrêter expose à une reprise de réplication. E : schémas simplifiés possibles et nombre de comprimés variable.

Q36 **À propos des schémas ARV évoqués, lesquelles des propositions sont justes ?**

Bonne réponse : A

L'enseignante cite bi-/trithérapies, comprimés combinés, et individualisation selon co-infections, grossesse, interactions et résistances.

Propositions à écarter : D et E : pas de schéma universel ni de jugement par simple nombre de comprimés. B : Le cours décrit des combinaisons en un comprimé. C : Les interactions, co-infections et comorbidités guident le choix.

Q37 **Quels noms de traitements combinés sont cités à titre d'exemples pendant la séance ?**

Bonnes réponses : A, B

Biktarvy, Dovato et Delstrigo sont les exemples de comprimés combinés cités oralement ; les molécules doivent être distinguées de celles des infections opportunistes.

Propositions à écarter : D : cotrimoxazole est évoqué pour pneumocystose. E : ganciclovir pour CMV. C : La prise en charge est individualisée.

Q38 **Une PVVIH bien contrôlée souhaite une grossesse. Quels messages sont conformes à la séance ?**

Bonnes réponses : A, D

La séance décrit des grossesses spontanées possibles et insiste sur l'observance, le contrôle virologique et le suivi spécialisé.

Propositions à écarter : B et E : des obligations/interdictions générales que l'enseignante rejette. C : Le contrôle de la charge virale est une priorité de la grossesse.

Q39 **Concernant l'allaitement chez une PVVIH contrôlée, quel raisonnement est approprié ?**

Bonnes réponses : B, C, E

L'enseignante explique l'évolution de la pratique : une discussion encadrée peut être proposée, avec forte vigilance sur la suppression virale et le suivi mère–enfant.

Propositions à écarter : A et D : les formulations absolues ne reflètent pas les nuances du cours.

Q40 **Quel rôle attribuer à la prophylaxie néonatale lors d'une grossesse chez une PVVIH ?**

Bonnes réponses : A, C, D

La séance évoque une prophylaxie néonatale et un suivi spécialisé, en complément du contrôle maternel.

Propositions à écarter : B : le suivi maternel est essentiel. E : la prophylaxie vise à prévenir, pas à affirmer une infection.

PrEP, TPE et rôle infirmier

10 questions

Q41 **À propos de la prophylaxie pré-exposition (PrEP), que faut-il retenir ?**

Bonne réponse : A

La PrEP est une prévention antirétrovirale anticipée, présentée comme un outil majeur de réduction du VIH.

Propositions à écarter : D : pas un vaccin. E : elle ne protège pas de toutes les autres IST. B : PrEP signifie prévention avant une exposition potentielle. C : La PrEP repose sur des antirétroviraux, non un vaccin.

Q42 **Quels messages sur la PrEP sont cohérents avec le cours ?**

Bonnes réponses : A, C

Le cours insiste sur l'information PrEP, notamment pour les personnes exposées et celles ayant eu une autre IST ; il présente voies orale et injectable.

Propositions à écarter : B : prévention des autres IST maintenue. E : traitement du VIH ≠ PrEP seule. D : Le cours indique des modalités et des disponibilités à vérifier localement.

Q43 **Qu'est-ce qui différencie PrEP et traitement post-exposition (TPE/PEP) ?**

Bonnes réponses : A, B

La différence temporelle est essentielle : prévention en amont (PrEP) et prise en charge urgente après exposition (TPE).

Propositions à écarter : D : médicaments antirétroviraux, pas vaccin. E : évaluation de la nature de l'exposition indispensable. C : Le TPE est une urgence évaluée au plus tôt, dans une fenêtre temporelle limitée.

Q44 **Quelles données d'une exposition récente doivent être recueillies en priorité ?**

Bonnes réponses : A, B, C

La séance rappelle qu'il faut identifier le moment et la nature du contact pour apprécier l'urgence et l'éligibilité au TPE ; l'équipe évalue le contexte.

Propositions à écarter : D : attitude non jugeante. E : une exposition pertinente doit être caractérisée.

Q45 **Quels repères de TPE sont explicitement donnés pendant le cours ?**

Bonnes réponses : A, B, C

La séance évoque un TPE urgent, idéalement dans les premières heures, dans les 72 h et pendant 28 jours, à adapter au protocole appliqué.

Propositions à écarter : D : ne pas différer l'évaluation. E : il s'agit d'antirétroviraux, pas d'un vaccin.

Q46 **Après un accident d'exposition au sang (AES), quelles étapes sont citées ?**

Bonne réponse : A

L'enseignante insiste sur l'urgence, les examens de suivi et la déclaration professionnelle pour l'IDE exposé.

Propositions à écarter : D : l'indication du TPE relève de l'évaluation médicale. E : traçabilité et suivi sont indispensables. B : La séance évoque les sérologies et contrôles appropriés. C : Le cours rappelle l'importance de cette déclaration.

Q47 **Dans le cas de M. M., anxieux après un rapport non protégé, quelle posture infirmière est adaptée ?**

Bonnes réponses : A, B

Le cas corrigé oralement insiste sur l'écoute, une information rassurante et exacte, le dépistage et le repérage d'un possible TPE.

Propositions à écarter : D : message alarmiste explicitement écarté. E : diagnostic inconnu. C : La date est déterminante pour une éventuelle orientation TPE.

Q48 **Un étudiant propose de résoudre les huit situations du cas final en cochant « TPE oui/non ». Que répondre à partir des sources fournies ?**

Bonnes réponses : A, C

Le cas final sur les expositions est présent dans les captures mais non corrigé dans l'enregistrement. Il doit rester en exercice de raisonnement sans clés inventées.

Propositions à écarter : B et E : une correction non sourcée ou une règle automatique seraient dangereuses. D : La transcription se termine sans correction de ces huit situations.

Q49 **Que comprennent les précautions et le rôle IDE auprès d'une PVVIH ?**

Bonnes réponses : A, B, C

La séance distingue VIH et transmission aérienne : les précautions standard protègent lors des gestes à risque, sans écarter les soins ordinaires.

Propositions à écarter : D : Air concerne notamment une tuberculose pulmonaire contagieuse. E : le contact ordinaire ne transmet pas le VIH.

Q50 **Quelles composantes de la prise en charge globale sont soulignées par l'enseignante ?**

Bonnes réponses : A, B, C

Le cours fait de l'éducation thérapeutique, de l'observance et du soutien social/psychologique des axes prioritaires de soins.

Propositions à écarter : D : relation et accompagnement indispensables. E : vaccination et IST restent abordées.

Repères de révision

Les traitements et les situations d'exposition à risque sont présentés pour la compréhension du cours. Toute décision réelle de dépistage, prophylaxie ou traitement suit une évaluation médicale et un protocole applicable. Le cas final de huit expositions n'ayant pas été corrigé à l'oral, aucune clé clinique n'a été attribuée à ces huit situations.